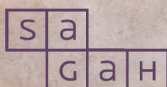


GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Mauro Vieira Saldanha



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Localização e processo da área de gestão de suprimentos nos hospitais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você vai apresentar os seguintes aprendizados:

- Listar as características da localização física da área de gestão de suprimentos em hospitais.
- Identificar a importância da gestão por processos na área de gestão de suprimentos em hospitais.
- Ilustrar os processos mais relevantes na área de gestão de suprimentos em hospitais.

Introdução

Neste capítulo, você vai compreender o papel estratégico da gestão de suprimentos e onde ela está inserida no contexto da gestão da cadeia de suprimentos em saúde. Essa inserção ocorre por meio do sistema de gerenciamento por rotina, que propicia identificar lacunas existentes na cadeia produtiva do hospital e fomentar a busca contínua por melhorias. Levando-se em consideração que a cadeia de suprimentos hospitalar representa um dos maiores custos do hospital, a viabilidade da operação, a sua adequada concepção, a sua arquitetura e o seu gerenciamento são fundamentais na busca pela excelência assistencial aos pacientes, com o viés logístico de menor custo total.

1 Localização da área de suprimentos hospitalar

Em hospitais, o não atendimento e/ou a interrupção no tratamento do paciente podem ser ocasionados por diversas razões, em especial, pela falta de materiais ou medicamentos na prestação dos serviços. A **gestão de suprimentos médico-hospitalares** tem forte impacto nesse contexto. Nesse sentido, a área de suprimentos deve ser planejada de forma que as suas características físicas possam permitir a plena integração dos diversos fluxos entre seus atores — materiais e informações.

Para o adequado suporte logístico médico-hospitalar e a sua necessária eficiência, é imperativo que os recursos sejam disponibilizados no momento certo, na quantidade exata, com a qualidade necessária e com o menor custo total possível. A definição da localização e das características físicas da área de suprimentos hospitalar tem papel relevante nesse processo. Assim, instituição, parceiros, equipes médicas e multidisciplinares terão condições adequadas para prestarem os serviços com o máximo nível de excelência.

A **logística hospitalar** e os suprimentos hospitalares, quando bem geridos, tornam-se um apoio estrategicamente eficaz quando estão unidos aos recursos humanos e à administração comercial. Para que haja um impacto positivo na assistência e no desenvolvimento de atividades em atenção à saúde, tais elementos necessitam de total atenção e acompanhamento. Avaliar o grau de maturidade da cadeia de suprimentos em um hospital se torna importante para conhecer, gerir, medir e controlar o sistema como um todo, visando a identificar processos e áreas críticas que podem ser melhoradas a partir de técnicas ou modelos de gestão adequados.

A partir do **mapeamento dos processos produtivos** de um hospital específico, é possível identificar as características necessárias para a localização e a arquitetura da sua área de suprimentos, bem como alinhar a sua função com a estratégia da instituição hospitalar. A sua localização física deve propiciar a sua integração com os demais setores hospitalares, e a sua implementação deve contemplar práticas de agregação de valor, como um diferencial competitivo na prestação de serviços, pois esses serviços envolvem assistentes e coordenadores nas áreas de compras, farmácia e armazenagem, além do gerente de suprimentos.

Nesse contexto, para agregar valor ao cliente final, todas as áreas devem estar conectadas e integradas ao planejamento estratégico organizacional. O desempenho da cadeia de suprimentos médico-hospitalar está vinculado

às suas características e a fatores específicos como: planta baixa do hospital, local de armazenagem (almoxarifado, farmácia e hotelaria), tipos de estoques (materiais e medicamentos), tipos de transportes utilizados, precificação dos serviços e até a sua logística reversa (tratamento de resíduos sólidos). Quanto maior essa efetividade física, mais eficientes serão os fluxos de materiais e de informações.

Modelos de distribuição a partir do arranjo físico

A definição da localização e das características físicas da área de suprimentos médico-hospitalares é um processo estratégico de gestão que tem impacto direto em sua **cadeia produtiva**.



Fique atento

A cadeia produtiva hospitalar contempla as logísticas de suprimentos, produção, distribuição e reversa.

- **Logística de suprimentos:** se refere aos materiais médicos e de consumo, além de medicamentos. Envolve desde o planejamento de demanda, a compra, o transporte, o recebimento, a armazenagem e a expedição interna.
- **Logística de produção:** se refere à elaboração de kits de medicamentos e/ou materiais (tratamentos clínicos, cirurgias etc.). Envolve a criação de produtos acabados e a sua armazenagem para consumo final.
- **Logística de distribuição:** se refere aos fluxos internos de materiais (almoxarifado) e medicamentos (farmácia). Envolve a expedição interna, o fracionamento e a aplicação junto ao paciente.
- **Logística reversa:** se refere ao descarte de resíduos (sólidos, líquidos, contaminados etc.) e à reciclagem de insumos (rouparia, por exemplo, quando não é terceirizada pelo hospital).

Não esqueça da importância da visão sistêmica dessa cadeia produtiva.

Para se estabelecer uma gestão de suprimentos eficaz, pode-se ter como parâmetro **modelos de distribuição** utilizados na administração de materiais de diferentes hospitais, considerando as suas características e as suas localizações físicas. A seguir, são apresentados três modelos distintos de distribuição de suprimentos.

Distribuição coletiva ou sistema de complementação da previsão

Os materiais e medicamentos são expedidos a subestoques nas enfermarias e unidades de internação. Todos os dias são realizadas as requisições para repor os materiais utilizados no dia anterior; no caso de medicamentos, a requisição é feita de acordo com a prescrição médica. O benefício dessa metodologia é a redução do trabalho da farmácia. As maiores desvantagens são o risco de perda de controle por parte da farmácia de armazenagem e o fato de se permitir que o controle dos materiais seja assumido pela enfermagem, ocasionando risco de desvio, deterioração e prazos de validade vencidos e maior possibilidade de falhas na medicação, ocasionadas pelo distanciamento do farmacêutico e do corpo clínico (prescrições médicas).

Distribuição semicoletiva ou sistema de unidades móveis

Os medicamentos são entregues por meio de requisições ou prescrições médicas diariamente. Assim, há redução de estoque de medicamentos dentro dos subestoques. Além dessa vantagem, o processo fica mais seguro, pois o farmacêutico sempre confere as prescrições médicas, minimizando os riscos de falhas na medicação distribuída. A desvantagem é o excesso de atividade por parte dos auxiliares e técnicos de farmácia, que pode ter como consequência atrasos no recebimento dos medicamentos.

Distribuição de medicamentos por dose-unitária ou sistema de ordem de produção

Os medicamentos são acondicionados em doses unitárias ou individualizadas para cada paciente, mediante a segunda via da prescrição médica. Esse processo é mais complexo e exige uma participação maior dos farmacêuticos, bem como maior investimento no que diz respeito à compra de embalagens e de etiquetas para identificação das doses unitárias. Mas os resultados compensam, pois as vantagens são percebidas pela redução de manipulação por parte da enfermagem, pela redução de erros na dispensação e na administração dos medicamentos e pela possibilidade de o farmacêutico verificar e controlar todas as prescrições.

2 Conceitos de logística hospitalar

Barbuscia (2006) considera a logística hospitalar inserida dentro da função de administração de materiais, enquanto Barbieri e Machline (2017) afirmam o contrário, ou seja, que a administração de materiais está contida na logística. Além dessa discrepância de ordem departamental, há também uma diferença quanto à abrangência da logística. Para o primeiro autor, ela se limita à atividade de distribuição interna de materiais. Já para Barbieri e Machline (2017), o escopo da logística é mais amplo, sendo responsável pela gestão de todos os fluxos de materiais e informações, desde os fornecedores até o leito dos pacientes.

Outra divergência constatada entre os autores é o enfoque nos distintos fluxos que compõem a gestão logística hospitalar. Barbieri e Machline (2009) enfatizam a logística como gestora dos fluxos de materiais e de informações, ao passo que autores como Vissers e Beech (2005) definem logística como gestora do fluxo de pacientes, sendo responsável direta pela gestão dos serviços de assistência terapêutica. Uma terceira abordagem possível, proposta por Carvalho e Ramos (2009), também compartilhada por Langabeer II (2008), é o somatório dos enfoques anteriores, em que a logística é responsável tanto por fluxos de materiais e informações quanto pelo fluxo de pacientes.

Por outro lado, há uma convergência de pensamentos quanto à complexidade da gestão de uma organização hospitalar, bem como da necessidade de a mesma contemplar em seu escopo o tripé **ferramentas, processos e pessoas**, cujos elementos são estruturados e conectados entre si. Uma ferramenta, por mais inteligente e bem customizada que seja, jamais será capaz de mudar a história de produtividade, controle e desempenho hospitalar. Além disso, ela precisa, obrigatoriamente, de pessoas que colocarão informações em sua base, que, processadas de maneira consistente e contínua, gerarão uma importante fonte de tomada de decisão.

Se os processos — fluxos de materiais e informações — não levarem para as pessoas treinamento e uma maneira otimizada de fazer as coisas, pouco contribuirão para a melhoria do desempenho e da produtividade hospitalar e, conseqüentemente, vão produzir uma base de informação desqualificada para as ferramentas. Complementarmente, é preciso investir nas pessoas, em sua qualidade de vida pessoal e profissional, para que elas possam gerar o aumento da produtividade que se espera, reduzindo desperdícios e, conseqüentemente, aumentando os lucros das empresas, suportadas pelas ferramentas e orientadas pelos processos.

O fato é que os componentes desse tripé não são fatores excludentes. As melhores práticas de mercado mostram que ações desfocadas e desencontradas podem, quando muito, ser consumidoras de muito investimento e pouquíssimo retorno. No setor hospitalar, por tamanha responsabilidade envolvida, já que lidam com vidas, as instituições estão submetidas a regulamentações de órgãos certificadores e acreditadores e lidam diariamente com o desafio de prover serviços de excelência. Nesse sentido de busca por excelência e qualidade total no atendimento e nas condições fornecidas aos pacientes, um olhar crítico sobre os seus processos, visando à melhoria contínua, é vital. “Os processos são a fonte de muitas das oportunidades de melhorias que existem dentro de uma organização. Melhorar processos significa melhorar a maneira como as atividades são executadas” (HANSEN; MOWEN, 2001, p. 475).

Os processos que passam por um bom gerenciamento possuem algumas características em comum:

- alguém responsável pelo desempenho do processo (o dono do processo);
- fronteiras bem definidas (o escopo do processo);
- interações internas e responsabilidades bem definidas;
- procedimentos, tarefas e especificações de treinamento documentadas;
- sistemas de controle e *feedback* próximos ao ponto em que a atividade é executada;
- controle e metas orientados para as exigências do cliente;
- prazos de execução conhecidos;
- disposição de procedimentos para mudança formalizados;
- certeza de o quanto podem ser bons.



Exemplo

No âmbito hospitalar, a gestão da área de suprimentos por processos é de extrema relevância para a obtenção dos resultados. Tomemos como exemplo a importância da gestão do processo de faturamento hospitalar. Se não estiver muito bem modelado, diversas rupturas podem ocorrer, gerando recorrentes atrasos nas suas diversas etapas e no recebimento de recursos monetários, impactando negativamente o desempenho financeiro do hospital. Essas rupturas também geram retrabalhos, o que gera aumento nos custos e, em última instância, impactam negativamente o desempenho financeiro da organização e a motivação e a satisfação dos colaboradores.

Fases da gestão de suprimentos hospitalares, por processos

A área de suprimentos, que provê suporte logístico ao hospital, quando gerida por um método assertivo, pode maximizar resultados e garantir a qualidade e a produtividade da organização hospitalar. A gestão de suprimentos hospitalares por processos é realizada em cinco etapas, incluindo uma fase diagnóstica, a definição de mudanças, a esquematização em fluxogramas, a implantação e um acompanhamento contínuo. Essas etapas são descritas a seguir.

1. Mapeamento — etapa do entendimento da situação atual, a partir de entrevistas com profissionais que participam dos processos para conhecer as suas demandas e a atual conjuntura dos fluxos hospitalares.
2. Modelagem — elaboração de um fluxograma, que vai resumir cada etapa, os participantes, os elementos componentes e as interações entre cada unidade.
3. Melhoria — identificação de procedimentos médico-hospitalares que precisam ser melhorados.
4. Implantação — o principal produto dessa etapa é a padronização. Nela, os gestores vão delimitar como devem ser realizadas as fases do processo e estabelecer uma norma para que qualquer profissional capacitado que assuma a área tenha a capacidade de executá-las.
5. Monitoramento — é a verificação de se as atividades estão sendo executadas em conformidade com o que foi planejado e se os resultados estão sendo positivos para o hospital e os demais atores.

A adoção dessa estratégia na área de suprimentos hospitalar é de extrema relevância, além de ser um diferencial competitivo. Ela proporciona melhor gestão de custos e integração entre os setores, com equipe multidisciplinar, melhorias na comunicação e elevação da produtividade.



Saiba mais

Os sete desperdícios da produção, segundo o sistema Toyota, são os seguintes

1. superprodução;
2. tempo de espera;
3. transporte;
4. processo;
5. estoque;
6. movimentação;
7. produtos defeituosos.

3 Os processos mais relevantes da área de gestão de suprimentos hospitalares

Nenhuma organização é autossuficiente ou vive isoladamente. Essa afirmação também é válida para o setor hospitalar. Além de precisar se relacionar com os seus pacientes, investidores e parceiros, a área de suprimentos de um hospital fomenta relacionamentos com fornecedores. Essa relação permite a continuidade operacional, bem como a otimização de todos os seus processos, a fim de caminhar rumo ao sucesso. Para Barbieri e Machline (2009), as atividades típicas da área de suprimentos em um hospital são, entre outras, as seguintes: seleção de materiais, compras, recebimento de materiais, gestão de estoques, armazenagem, distribuição e atendimento aos pacientes. A seguir, são descritas as atividades mais relevantes dessa área.

Seleção de materiais

Após a definição do modelo de dispensação de medicamentos, precisam ser definidos os tipos de medicamentos e materiais que serão utilizados. Assim, é possível identificar o insumo correto para as características de atendimento. Trata-se de uma etapa extremamente relevante para a operação, que precisa ser realizada por uma gestão que seja capaz de atender às diversas exigências e atingir consenso entre os vários atores do processo: área financeira,

faturamento (na unidade privada de saúde), farmacêutico, comprador, corpo clínico e usuários. A seleção de medicamentos traz para o hospital vantagens administrativas, com a redução de custos, e vantagens assistenciais, melhorando a qualidade da farmacoterapia desenvolvida na instituição, conforme apontam Gomes e Reis (2001).

Especificação de materiais

Barbieri e Machline (2017) defendem que uma descrição adequada permite eliminar confusões com materiais similares. Os seguintes critérios devem ser observados para uma correta descrição:

- descrever o material partindo do geral para o particular;
- incluir todas as informações necessárias para identificá-lo de modo a não gerar dúvidas;
- evitar características desnecessárias ou redundantes;
- usar terminologia padronizada.

A descrição deve contemplar o nome básico, o nome modificador, as características físicas, a unidade metrológica e as identificações complementares, que devem fazer parte de uma estrutura básica para descrever corretamente os materiais. Para medicamentos, torna-se necessário incluir a denominação genérica do produto, a forma farmacêutica, a concentração, o prazo de validade, o registro no Ministério da Saúde e o tipo de embalagem, conforme complementam Barbieri e Machline (2017).

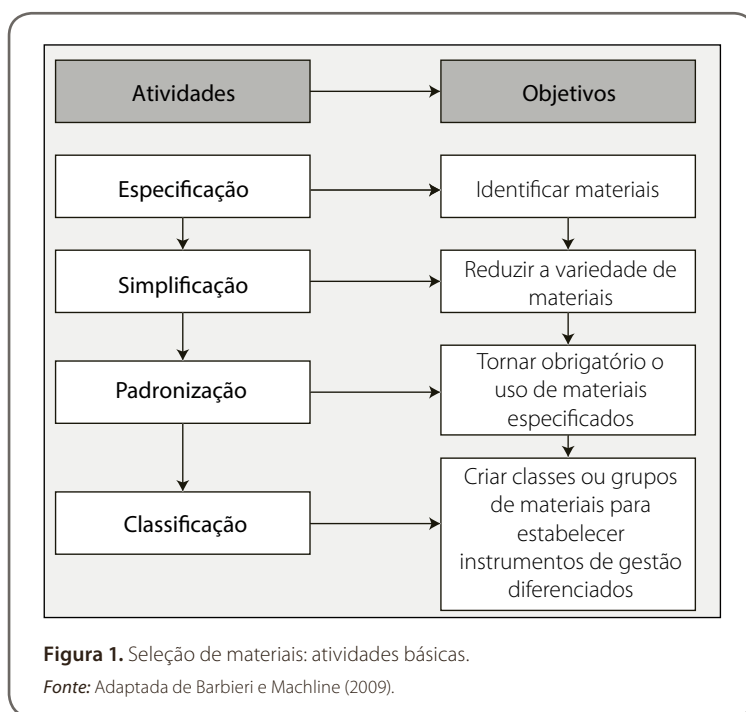
Gestão de estoques

É extremamente estratégico realizar o controle de tudo o que entra e sai na cadeia produtiva do hospital, pois é uma ação fundamental para se obter os melhores resultados possíveis. A principal razão é que, sem monitoramento, é impossível identificar e corrigir problemas. A boa gestão de estoques é vital para que a operação tenha a eficiência e a eficácia desejadas. Podemos pensar em vários gastos desnecessários, por exemplo, que uma má gestão do estoque pode gerar e no seu impacto negativo.

É necessário acompanhar de perto detalhes como: quais são as condições de armazenamento ideais? Nossos produtos têm sofrido impactos que têm gerado perdas e ou desperdícios? Estamos comprando além do necessário? Existem materiais que recorrentemente faltam e causam a interrupção dos serviços assistenciais? Esses questionamentos são necessários e nos mostram como a gestão de estoque inadequada pode afetar a operação dentro de um hospital. Podem ser feitas diferentes análises nesse processo de gestão, como:

- classificação ABC de estoques;
- classificação ABC de consumo;
- classificação ABC de venda ou faturamento;
- classificação ABC de fornecedores.

De forma ilustrativa, a Figura 1 traz um esquema com as atividades básicas do processo de seleção de materiais.



O enfoque logístico na área de gestão de suprimentos hospitalar deve englobar:

- auditoria de materiais (especificação);
- serviços de farmácia (central e satélites);
- proteção contra perdas e danos (automação, com a adoção de identificação por radiofrequência, por exemplo);
- serviços de nutrição;
- eliminação de desperdícios;
- serviços de lavanderia hospitalar, manutenção, etc.

Neste capítulo, foi propiciada uma visão sistêmica sobre a importância da localização e dos processos da área de gestão da cadeia de suprimentos hospitalar, bem como sobre como elas estão interligadas e diretamente relacionadas aos resultados operacionais. Trata-se de variáveis extremamente relevantes e que devem ser tratadas de forma estratégica para o cumprimento de um atendimento com a excelência esperada por todos os atores envolvidos.



Referências

BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. *Logística hospitalar: teoria e prática*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. *Logística hospitalar: teoria e prática*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

BARBUSCIA, C. S. Gestão de suprimentos na administração hospitalar pública. In: GONÇALVES, E. L. (org.). *Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno*. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 196–224.

LANGABEER II, J. R. *Health care operations management: a quantitative approach business and logistics*. Sudbury: Jones and Bartlett, 2008.

VISSERS, J.; BEECH, R. (ed.). *Health operations management: patient flow logistics in healthcare*. New York: Routledge, 2005.

Leituras recomendadas

ARAÚJO, L. C. G. de; GARCIA, A. A.; MARTINES, S. *Gestão de processos: melhores resultados e excelência organizacional*. São Paulo: Atlas, 2011.

BALLOU, R. H. *Logística empresarial*. São Paulo: Atlas, 1998.

BOWERSOX, D. et al. *Gestão logística da cadeia de suprimentos*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

CARVALHO, J. C. de; RAMOS, T. *Logística na saúde*. Lisboa: Edições Sílabo, 2009.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. *Farmácia hospitalar: enfoque em sistema de saúde*. 2. ed. Barueri: Manole, 2010.

DIAS, M. A. P. *Administração de materiais: uma abordagem logística*. São Paulo: Atlas, 1998.

GURGEL JÚNIOR, G. D.; VIEIRA, M. M. F. Qualidade Total e administração hospitalar: explorando disjunções conceituais. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, v. 7, nº. 2, p. 325–334, fev. 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232002000200012&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 5 jul. 2020.

JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. *Administração de operações e da cadeia de suprimentos*. Porto Alegre: AMGH, 2012.

MALIK, A. M.; TELES, J. P. Hospitais e programas de qualidade no estado de São Paulo. *Revista de Administração de Empresas*, v. 41, nº. 3, p. 51–59, jul./set. 2001. Disponível em: https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75902001000300006.pdf. Acesso em: 5 jul. 2020.

PATERNIO, D. *A administração de materiais no hospital: compras, almoxarifado e farmácia*. 2. ed. São Paulo: Cedas, 1990.

TOLEDO, A. F. de. *Ecoeficiência: um estudo a respeito das instituições hospitalares no município de Santo André*. 2005. 160 f. Dissertação (Mestrado em Sistema Integrado de Gestão) — Faculdade de Educação Ambiental, Centro Universitário SENAC, São Paulo, 2005.

VECINA NETO, G.; REINHARDT FILHO, W. *Gestão de recursos materiais e de medicamentos*. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. (Série Saúde e Cidadania, 12).

VIANA, J. J. *Administração de materiais: um enfoque prático*. São Paulo: Atlas, 1999.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais links.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS